

NS

MARCELO DE PAULA LIMA

IDADE: 57a PESO: 83 ALTURA: 179 PROFISSÃO: Tec. Gestão.
 SINTOMAS: Sonolência / Causaço / memória Deficit / Concentr.
 QUEIXAS: Edema em m m I leve.
 MEDICAMENTOS: Result. / Escitalopram (20 anos).

MÉDICO: Drº Flávio / Drº Galeano

EXERCÍCIO FÍSICO: Musc.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 19h.

HORA QUE DORME: 22-23 HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILHO (X)SIM ()NÃO 30' DORME ACOMPANHADO ()SIM ()NÃO (X)EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA NÃO *às vezes.*

FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: II IAH: 49.7 SPO2: 85%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N)NASAL (N)AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (X)ENDÓCRINA (X)CARDÍACA

(X)ORTOPÉDICA (N)NEUROLÓGICA ()OUTROS

Dor lombar

03/10/23 - avaliação G.G cmH₂O.

10/10/23 P= 6.6 cmH₂O melhora do causaço,
IAH = 0.6 e/ev e sonolência diurna.
Fuga = 9.6 *fuor.*

26/10/23 P= 6.6 cmH₂O * Oriento que se
IAH = 0.8 e/ev posiciona em lateral.
M. de uso: 5h36'
Bem adaptado, relato alívio na lombar

07/11/23 P= 6.6 cmH₂O ↓ edema m m I.
IAH = 0.2 e/ev *fuor.*
M. de uso: 6h.

08/12/23 P= 6.6 cmH₂O *fuor.*
IAH = 0.5 e/ev
M. de uso = 5h54'

12/01/24 P= 6.6 cmH₂O Relata melhora da
IAH = 1.2 e/ev sonolência.
M. de uso: 6h15' *fuor.*
fuga = 21.3 l/min.

15/02/24 P= 6.6 cmH₂O Bem adaptado.
IAH = 0.8 e/ev *fuor.*
M. de uso = 6h10'
Fuga = 20.3

21/03
24 P = 6.6 cmH₂O
IAH = 1.2 e/ev
M. de uso: 5h46'
Fuga = 18.8 lpm.

Relata que a memória
está melhor.

trocar o bço.

Jua

24/04
24 P = 6.6 cmH₂O
IAH = 1.0 e/ev
M. de uso: 5h43'
Fuga = 21.5 lpm.

Bem adaptado
Oriento sobre exerc. físico
Jua

20/06
24 P = 6.6 cmH₂O
IAH = 0.9 e/ev
M. de uso: 5h29'

Bem adaptado, oriento a fazer o diário do sono.
Jua

21/08
24 P = 6.6 cmH₂O
IAH = 0.9 e/ev
M. de uso: 5h38'
Fuga = 19.1 lpm

Bem adaptado, alguns dias
utiliza para dormir na
cama da namorada
Refere diário do sono

22/11
24 De 30d usou 27d.
P = 6.6 cmH₂O
IAH = 1.2
Fuga = 23.3 lpm

Natasha

Bem adapt.

Troco o bço da mãe. Jua.

08/02
25 P = 6.6 cmH₂O
IAH = 1.4 e/ev
M. de uso: 8h

Bem adapt., sem queixas.
O calor está atrap.
Jua claudia

05/05
25 P = 6.6 cmH₂O
IAH = 1.3 e/ev
M. de uso: 5h43'
Fuga = 13.8 lpm.

Jua

CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 69.730

CRM-SP 62.958

PSIQUIATRIA
**LAUDO DA
POLISSONOGRAMA**

NOME: Marcelo de Paula Lima

EXAME nº: 5440-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado

DATA: 28/08/2023

IDADE: 57 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h40min e concluído às 06h03min. A latência para o sono foi de 8 minutos e a latência para o estágio REM, de 162 minutos. O tempo total de sono foi de 401,5 minutos (06h41min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 90,4%. A distribuição do sono mostrou 11,7% de estágio 1, 60,5% de estágio 2, 18,8% de estágio 3 e 9% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 34 minutos em vigília, ocorreram 70 microdespertares (índice: 10,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0,5/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 4,5/hora, sendo 0,8 apneia/hora e 3,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 4,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 92% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,2 cm de H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (4,5/hora; índice normal: 4/hora) e de distúrbio respiratório (4,5/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. O ritmo cardíaco foi sinusal e as frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 71 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 8 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 22h00min. A latência para o sono REM estava alongada (162 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (90,4%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (10,5/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (11,7%; normal: 8-10%), 2 (60,5%; normal: 45-55%) e 3 (18,8%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (9%; normal: 20%).

O índice de movimentos periódicos de membros (0,5/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Marcelo de Paula Lima
EXAME nº: 5440
SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado
DATA: 21/07/2023
IDADE: 57 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP: 62.856
CRM-SP: 69.730

LAUDO DA
POLISSONOGRAFIA

NOME: Marcelo de Paula Lima
EXAME nº: 5440-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado
DATA: 28/08/2023
IDADE: 57 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h59min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 17 minutos e a latência para o estágio REM, de 183 minutos. O tempo total de sono foi de 397,5 minutos (06h37min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 82,1%. A distribuição do sono mostrou 13,7% de estágio 1, 43,4% de estágio 2, 14,6% de estágio 3 e 28,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 69 minutos em vigília, ocorreram 106 microdespertares (índice: 16/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 49,7/hora, sendo 2,1 apneia/hora e 47,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 56,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 91% e a mínima de 85%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (49,7/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (56,5/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 53; máxima: 69 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 17 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (183 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 82,1%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 16/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (13,7%; normal: 8-10%), 3 (14,6%; normal: 10-12%) e REM (28,3%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (43,4%; normal: 45-55%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Flavio Augusto Passarelli Prado

ORINOLARINGOLOGIA

100701

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP
Especializado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Marcelo de Paula Lima

Solicito adaptação de CPAP a pressão sugerida de
6,2cmH₂O para tratamento de síndrome da apneia do
sono.

G47.3

Dr. Flavio A. P. Prado
Otorrinolaringologista
CRM : 100.701

28/09/2023

Rua Heitor Villa Lobos, 1450.
São José dos Campos - SP

CEP 13245-280 Tel (12) 3922-6793 - 3922-5881